

사실 감정 코멘트



수면장애의 경우 지속 기간 3주를 기간으로 3주 미만이면 일과성, 3주 이상 지속 시 만성으로 분류합니다. 일과성 수면장애의 경우 특히 수면위생의 변화, 스트레스, 약물, 급성 신체 질환 등에 의해 유발될 수 있으므로 관련된 요인을 문진하고, 해당하는 문제들을 먼저 교정하는 시도를 하여야 합니다. 3주 이상 지속되는 만성 수면장애의 경우 우울증과 같은 정신/신경 계통 질환 또는 수면무호흡증, 하지불안증후군과 같은 기질적 문제가 원인이 될 수 있으므로 추가적인 검사를 진행해봐야 합니다. 참고로 수면-각성장애의 경우 **중상이 3개월 이상, 주 3회 이상 지속되는 것이 진단 기준에 포함된 것을 인지하도록 합니다.** 또한 수면의 경우 렘수면과 비렘수면으로 나뉘며, 렘수면에 이상이 있을 시 기면증, 악몽, 렘수면 행동 장애가, 비렘수면에 이상이 있을 시 야경증, 몽유병, 공황발작 등이 발생할 수 있다는 것을 기억하기 바랍니다. **소아의 경우 신경계의 미성숙적 발달로 인해 야경증, 몽유병, 악몽** 등을 나타낼 수 있습니다.

병력 청취 시 **수면장애의 양상, 수면장애의 원인이 되는 정신과적 혹은 신체적 질환의 유무, 수면 위생을 확인**해야 합니다. 수면장애의 양상의 경우 잠들기가 어려운지, 유지가 어려운지, 침대에 얼마나 누워 있으며, 실제 수면 시간은 얼마나 되는지, 수면 주기의 이상이 있는지, 낮에 과도하게 졸린지, 자기는 하나 잔 것 같지 않은지, 코골이가 심한지 등을 확인해야 합니다. 수면위생의 경우 취침 전 저녁에 무엇을 하는지, 잠자리 환경, 잠이 안 오는 경우 대처, 자다 깬 경우 대처 등을 확인해야 합니다.

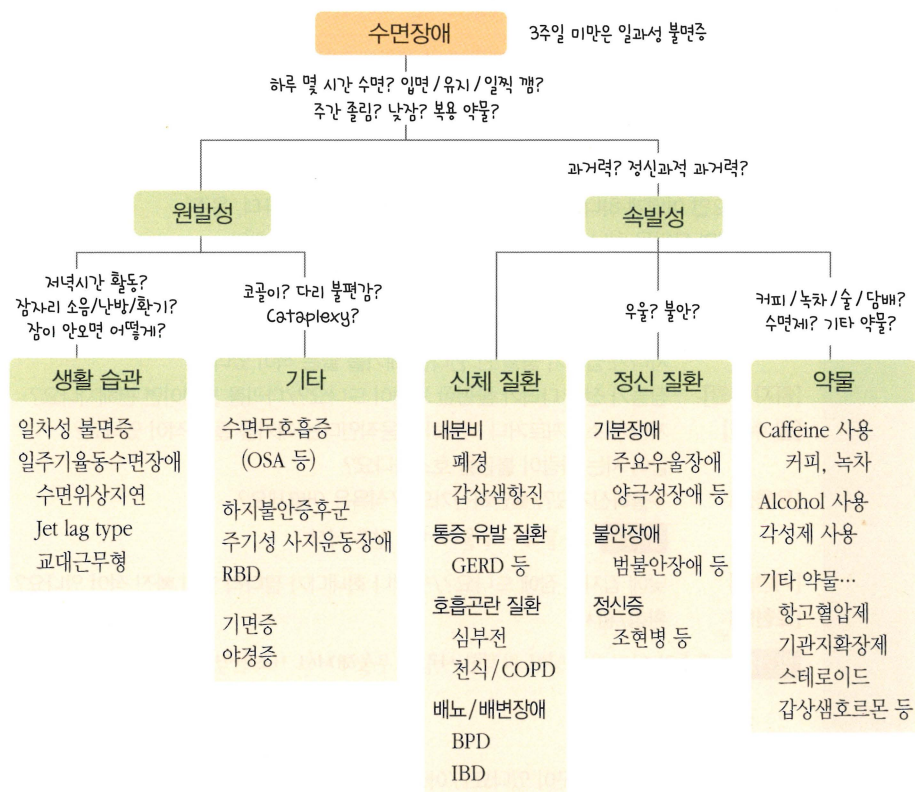
신체 진찰에서 **내분비 질환 중 갑상샘 질환을 감별하기 위해 목 진찰**을 해야 하며, 심장 질환 및 호흡기 질환 유무를 확인하기 위해 심음 및 호흡기 진찰을 수행해야 합니다. 또한 수면무호흡증의 위험 요소가 있는지 확인하기 위해 **키, 체중, 구강검사를 통해 턱의 폭, 목젖 등을 확인**해야 합니다.

환자 교육 시 **수면위생 개선에 대한 교육**을 하여야 합니다. 저녁에 운동하는 것, 음주 또는 커피 섭취가 많은 것도 수면을 방해하는 요인이므로 이에 대한 조정이 필요하며, 잠이 들지 않을 경우 계속 누워있는 것이 아니라 일어나 명상, 독서 등 몸을 이완시키는 행동을 할 것을 교육해야 합니다. 검사 설명 시 수면다원검사의 경우 검사를 위해 병원에서 하루 자고 가야하며, 일정이 편찮은지 물으면 라보 형성에 도움이 됩니다. 환자가 우울증 등 **정신 질환이 의심되면 심리검사 등의 정신 상태 평가가 필요하다는 것을 잘 설명**해 주어야 합니다. 치료에서 환자가 불면 증상으로 수면제를 요구할 경우 **수면위생 관리 및 행동 치료가 선행돼야 하며, 이후에도 개선이 안 될 시 필요할 때만 수면제를 사용해 부작용을 막는 것이 중요하다고 설명**해줘야 합니다. 소아 환자의 경우 질환의 경과 등을 설명해 부모님을 안심시키는 것도 라보에 도움이 되겠습니다.

계통	질병	진단 키워드	검사/치료
원발성 수면장애	불면장애★ (insomnia disorder)	[병력] 수면장애와 주간 증상이 최소 1주일 3회 이상, 3개월 이상 지속(기질적 질환, 원인 약물 없이)	[검사] 수면다원검사 (polysomnography) [치료] 수면 위생 개선, 인지 행동 치료(이완요법, 수면 제한, 자극 통제), 약물 치료는 소량으로 단기간(BZD)
	하루 주기 울동 수면장애★ (circadian rhythm sleep disorder)	[병력] 낮에 자고 밤에 일하는 교대근무자, 수면 패턴과 신체적/사회적 활동 패턴이 맞지 않음	[검사] 수면다원검사 [치료] 목표에 맞추어 수면-각성 주기 조절, 광치료, 멜라토닌
	폐쇄수면무호흡★ (obstructive sleep apnea)	[병력] 비만, 코골이, 자고 일어나도 깨운하지 않음, 주간 졸림 [검진] 편도가 크고 목젖이 길어 기도가 좁음	[검사] 수면다원검사 [치료] CPAP, 옆으로 자기, 체중 감량, 수술적 치료
	하지 불안증후군★ (restless legs syndrome)	[병력] 고령, 임신, 신장 질환, 빈혈, 정신과 약물 복용, 자기 전에 다리가 불안함	[검사] 수면다원검사, 철분검사 [치료] 철분 보충, Dopamine agonist (Pramipexole, Ropinirole)
	주기성 사지 운동장애 (periodic limb movement disorder)	[병력] 자다가 자꾸 깨고 낮에 졸림, 입면장애, 수면 중에 주기적으로 상동적인 사지 운동(주로 하지)	[검사] 수면다원검사 [치료] 철분 보충, Dopamine agonist(Pramipexole, Ropinirole)
	렘 수면 행동장애 (rem sleep behavior disorder)	[병력] 노인, 잘 때 소리 지르거나 과격한 행동을 해 옆에 있는 사람이 맞음	[검사] 수면다원검사 [치료] 안전한 수면 환경 조성, Clonazepam, Melatonin
	기면병 (narcolepsy)	[병력] 수면 발작, 탈력 발작, 잠에 들거나 깰 때 환각이나 마비	[검사] 수면 잠복기 반복검사, 야간수면다원검사, CSF hypocretin [치료] Modafinil(수면 발작), SSRI(탈력 발작, 환각, 수면마비)

원발성 수면장애	야경증★ (night terror)	[병력] 소아, 수면 중 소리지르면서 일어남, 악몽, 교란수면장애	[검사] 수면다원검사 [치료] 안전한 수면 환경 조성, 보호자 안심 및 지지, 심한 경우 정신 치료
	몽유병★ (Sleep walking, somnambulism)	[병력] 밤에 잠든 후 주로 1~2 시간 후 일어나서 돌아다님, 때로는 옷을 입거나 음식을 먹는 등 일상적인 활동을 수행할 수 있음, 멍한 표정 지음, 몽유병 삽화 중 깨우기 힘들며, 남들과 의사소통을 하지 못함, 야경증과 동반되는 경우가 있음	[검사] 수면다원검사 [치료] 경과 관찰, 수면 위생 개선, 약물이 유발 원인인 경우 약물 중단, 심한 경우 benzodiazepine
	악몽 (Nightmare)	[병력] 수면 시간 절반 이후, 새벽에 주로 발생, 굉장히 선명한 꿈을 꾸고 땀을 흘리거나 가슴이 두근거리며 깬, 쉽게 깨고 깬 이후에도 꿈 내용을 잘 기억함	[검사] 수면다원검사 [치료] 경과 관찰, 스트레스 줄이기, PTSD와 동반된 경우 약물 치료 가능
속발성 수면장애	주요 우울장애 (MDD)	[병력] 우울, 의욕 저하, 식욕 저하, 죄책감, 피로	[검사] Beck 우울척도검사 [치료] SSRI
	물질/약물 사용으로 유도된 수면장애 (substance/medication-induced sleep disorder)	[병력] 물질/약물 오남용	[검사] - [치료] 약물 중단/감량, 대체 약물 투여
	물질/약물 사용으로 유도된 수면장애	[병력] 알코올/카페인, 수면제, 기타 약물 오남용	[검사] 혈액검사 [치료] 물질/약물 중단/감량, 대체 약물 투여
	폐경으로 유도된 수면장애	[병력] 얼굴 화끈거림, 예민해짐, 무기력감	[검사] 혈중 FSH, Estradiol 농도검사 [치료] 호르몬 대체요법
	신체 질환으로 유도된 수면장애	[병력] 현재 앓고 있는 질환/아픈 곳 있는지 묻기	[검사] 원인에 따른 검사 [치료] 기저 질환 치료, 통증 조절

*일차성 불면증(Primary insomnia)은 DSM-5에서 불면장애(insomnia disorder)로 변경



기본 진찰 사항

STEP 1 병력 청취

O	언제부터 잠이 안 오기 시작하셨나요?/그때부터 줄곧 잠을 잘 못 주무시나요? (아니라면 일주일에 몇 일 정도 잠을 잘 못 자는지 확인) 불면 증상이 갑자기 시작되었나요?
L	잠은 보통 어디서 주무세요? → 외근이 잦은 지, 잠자리 주변 환경 등
D	하루에 몇 시간 주무시나요?/이전에는 몇 시간 주무셨나요? 몇 시에 자서 몇 시에 일어나나요?/중간에 깨나요?

Co	점점 더 심해지나요?
Ex	이전에도 이런 적이 있나요?/수면제를 드셔본 적이 있나요?/효과가 있던가요?
C	자고 일어나면 개운한가요?/졸음 때문에 낮 생활에 지장이 되나요?/낮잠을 자나요? <수면 위생 질문> 잠자리 들기 전 저녁 시간을 어떻게 보내시나요? → 자기 전에 음식, 운동, 흡연 등 잠자리 주변 환경은 편하고 아늑한가요? → 소음, 난방, 환기 잠이 안 오면 어떻게 하나요? → 누워서 계속 기다림, TV, 컴퓨터, 음주 자다가 깨면 무엇을 하나요? → 물 마시기, 담배 피우기, 시계 확인 [전신] 열, 체중 변화
A	[수면무호흡] 키와 체중이 어떻게 되시나요?/코를 고시나요? 자다가 갑자기 숨을 안 쉰다는 얘기를 들은 적이 있나요? [하지 불안] 잠들기 전에 다리가 불편한 느낌이 드나요?/다리를 움직이면 편해지나요? [렘 수면] 자다가 소리지르거나 과격하게 움직인다는 얘기를 들은 적이 있나요? 같이 자는 사람이 불편을 호소하나요? [우울증] 우울하신가요?/불안하신가요?/식욕은 어떠세요? 암기법 우불식 - 우울해서 불 같은 식사 [기면증] 낮에 갑자기 잠에 드나요?/웃거나 화내다가 팔다리 힘이 빠진 적이 있나요? [조현병] 환청/환시 암기법 호흡과 다리 움직임이 과격한 사람은 우울해져서 기초면역이 약해져 신체 질환을 앓게 된다. <신체 질환> [Open] 특별히 불편한 곳이 있나요?/아픈 곳이 있나요?(통증) [갑상샘항진증] 더위를 잘 못 참으시나요?/최근 체중이 줄었나요?/두근거리나요? [천식] 기침/호흡곤란/쌉쌉거림 [GERD] 속이 쓰린가요?/신물이 올라오시나요?/가슴이 아픈가요? [전립샘] 밤에 소변을 보기 위해 자주 깨시나요?/소변 보기 힘든가요? 암기법 O갑천신전 - open + 목 3개 + 소변 설명 Open, 갑상샘(더위, 체중, 두근), 천식(기침, 호흡, 쌉쌉), GERD(속쓰림, 신물, 흉통), 전립샘 <소아의 경우> [NREM/REM 사건수면의 감별] 아이가 잠에서 깼을 때 꿈을 잘 기억하나요? 수면 중 깨우면 의식이 완전히 돌아오나요? 수면 전반/후반 중 언제 event가 발생하나요? [불면증] 잠을 재워주지 않으면 잠에 들지 않나요?/밤에 여러 번 깨나요? 잠자리에 들지 않으려고 하나요?

	[아경증] 깰 때 소리를 지르면서 깨기도 하나요?/크게 보채다가도 다시 별 일 없이 자기도 하나요?/빈맥/빈호흡/식은땀 [약동] 깰 때 소리를 지르면서 깨기도 하나요?/빈맥/빈호흡/식은땀 [몽유병] 자다 일어나서 구체적인 활동을 하나요?/무슨 활동을 하나요? 활동 중 의사소통이 가능한가요? [뇌전증] 자는 중에 몸이나 얼굴을 움직이기도 하나요?/특정한 움직임이 반복되나요?
F	잠을 못 자는 특별한 요인이 있으신가요? 최근 생활 패턴의 변화가 있었나요?(근무 시간 변화 → 직업 확인/해외 여행) 스트레스를 많이 받으시나요?
E	-
외	수술 받으신 적이 있나요?/최근 외상을 입으신 적 있나요?
과	진단 받은 질환이 있나요? → 고혈압 정신건강의학과에 진료 받으신 적이 있나요?
약	현재 복용하시는 약물이 있나요? - 불면증 유발 약물 : 항고혈압제, 기관지확장제, 스테로이드, 비염약(비충혈제거제)
사	술을 드시나요?/담배를 피시나요? 커피나 녹차를 드시나요? 하루에 몇 잔 드시나요? 밤에도 드시나요?
가	가족 중 수면 질환이 있으신 분이 계신가요? 가족 중 정신건강의학과 진료를 받은 분이 있나요?
여	[월경력] 월경을 규칙적으로 하시나요? or 폐경을 하셨나요? → 얼굴이 화끈거리나요?/예민해졌나요?
P/E	이제 신체 진찰을 하도록 할텐데요, 괜찮으신가요? 오늘 측정한 활력 징후는 정상입니다(이상 소견이 있는 경우 언급해 주기). [앉아서] 1. 눈 : 결막(빈혈, 충혈) 2. 입★ : 설악자를 이용하여 편도, 목젖 확인 3. 목 : 갑상샘 촉진 4. 가슴★ : 심음 청진(최소 5군데)/호흡기계 시진-촉진-타진-청진 5. 피부 : 하지 오목 부종(pitting edema) → 협조해 주셔서 감사합니다. 불편한 것은 없으신가요?

STEP 2 환자 교육

공감	그동안 잠을 잘 못 주무셔서 많이 힘드셨을 것 같습니다.
추정 진단	지금까지의 문진과 신체 검진 소견을 종합해 보았을 때 흔히 불면증으로 알고 있는 불면장애가 가장 의심됩니다.
감별 진단	하지만 그 외에 갑상샘 질환이나 약제 등의 원인도 완전히 배제할 수 없습니다.
검사	정확한 진단을 위해 야간수면다원검사, 갑상샘기능검사 등이 필요할 것으로 생각합니다. 검사를 위해 병원에서 하루 주무셔야 하는데 괜찮으신가요? [정신 질환이 의심될 경우] 또한 환자분의 경우 우울증 등의 정신 질환이 의심돼 심리검사를 통해 이에 대한 평가가 필요합니다.
치료	만약 검사로 다른 원인이 배제되고 불면장애로 확진되면 치료로 가장 중요한 것은 생활습관 교정입니다. 아주 심할 때만 복용하실 수 있게 수면제도 처방해 드리겠습니다.
예후	지금부터 잘 치료를 받으시면 호전되실 수 있습니다. 증상이 있을 때 병원에 잘 오셨습니다.
환자 교육	[안심시키기] [노인의 경우] 생리적으로 수면주기가 앞당겨지고 잠자는 시간이 줄어 들 수 있습니다. 지나친 불면에 대한 집착은 오히려 수면장애 증상을 악화시킬 수 있습니다.
	[수면 위생] 잠을 잘 주무시기 위해서는 약물 치료는 일차적 치료 선택이 아니며, 반드시 수면 습관과 생활 습관의 개선이 동반되어야 합니다.
	건강한 수면을 취하기 위해서는 규칙적으로 취침, 기상하시고 불규칙한 낮잠은 되도록 피해야 합니다. 평소에는 식사를 조절하고, 적당한 운동을 하되 자기 전에는 야식과 과한 운동은 피하셔야 합니다. 그리고 침실 주변을 조용하고 쾌적하게 하셔야 합니다.
	잠이 안 올 때는 억지로 누워있기 보단 침실에서 나와서 독서나 명상 같은 다른 활동을 해보는 것이 좋습니다. 마지막으로 술, 담배, 커피는 모두 불면증에 악영향을 미칩니다. [수면제 사용] 수면장애의 경우 수면제 처방 전에 수면 위생 관리 및 행동 치료를 먼저 진행해 보는 것이 좋습니다. 이런 노력 이후에도 지속적으로 불면 증상의 호전이 없다면 적절한 수면제를 필요할 때만 단기간 사용해 볼 수 있습니다. 하지만 불필요한 수면제의 사용은 의존, 내성, 금단 등의 위험이 있어 필요할 때만 사용하는 것을 권장합니다.

[소아의 경우]

아이가 밤에 잘 못 자고 자주 깨서 많이 걱정되실 텐데, 야경증은 기본적으로 가만히 두면 저절로 사라지기 때문에 안심하셔도 됩니다. 또한 야경증이 성장이나 발달에 지장을 준다는 증거는 별로 없기 때문에 이 역시 걱정하지 않으셔도 됩니다. 아이 잘 달래주시고, 말씀드린 수면 위생만 잘 지켜도 괜찮아지는 경우가 대부분이지만, 만약 증상이 지속되는 경우에는 약물을 소량 쓰는 것을 고민할 수 있겠습니다.

질문 마지막으로 혹시 궁금한 점이 있으신가요?

❖ 기본적 진단 계획

- ① 수면다원검사(polysomnography)
- ② 혈액검사 : TFT(total T3, free T4, TSH), serum FSH, serum Estradiol

❖ 치료 계획

- ① 필요 시 수면제 처방, 수면일지 작성, 바이오피드백 치료, 인지 행동 치료(이완요법, 수면제한, 자극 통제)
- ② 안심시키기 : 하루에 5~6시간만 자도 괜찮다. 노인은 생리적으로 잠이 줄어들 수 있다.
- ③ 수면 위생 교육

❖ 환자 안내/생활 습관 교육

- ① 수면제의 기능과 장·단점 설명 : 삶의 질 향상, 수면 시간 연장, 수면 중 깨는 횟수 감소

• 약물 치료 → 수면 위생으로 호전 없을 때 처방

- Benzodiazepine : 수면, 진정, 항불안, 부작용의 빈도와 정도가 낮으면서 단기 치료에 효과적
- 비 Benzodiazepine : 의존, 남용은 적지만, 부작용의 위험
- 멜라토닌 수용체 작용제 : 수면-각정 주기에 관여, 남용이나 인지장애 없다.

② 수면 위생 : 3가지 이상 교육

- 기상, 수면 시간 일정하게 하기, 낮잠 금지
- 카페인, 니코틴, 알코올 등 물질 피하기(수면을 파편화시킴)
- 침실의 온도와 소음을 적절하게 조절해 편안하게 만들기
- 침실에서 기타 활동 피하기 : 침실은 오직 수면과 성적 활동의 공간
- 잠을 잘 수 없다면 침대에서 나오고 다시 졸릴 때 들어가기
- 자기 자신의 침실에서 자기
- 수면 2시간 전에는 운동 피하기
- 수면 전 30분간 이완 운동 or 90분 전 샤워/목욕을 통한 수면 준비하기
- 매일 30분~1시간 정도의 운동을 규칙적으로 하기

③ 수면제는 장기간 사용 시 의존, 내성, 금단 등의 위험이 있으므로 필요할 때만 쓰고, 의존성이 적은 수면제를 사용하도록 권장



keyword

3주 기간을 기준으로 일과성, 만성 수면장애로 구별해 감별하기, 수면-각성장애의 경우 렘수면, 비렘수면 장애로 구별해 감별하기, 소아의 경우 신경계 미숙으로 인한 야경증, 몽유병, 악몽 의심하기

병력 청취 : 수면위생, 동반되는 정신과적 증상, 신체 증상에 대해 확인하기

신체 진찰 : 키/체중/구강검사를 통해 턱의 폭, 목젖 이상 확인하기, 갑상샘 질환 등을 진단하기 위해 목 진찰하기, 심장 호흡기 진찰 위해 호흡음/심음 청진하기

환자 교육 : 수면위생 개선 교육하기, 정신 질환 의심 시 심리검사 의뢰하기, 수면제 남용 방지 교육하기